

6 - 06- Les Céphalées et les Algies vasculaires de la face- Pr. Kissani

Donc bonjour nos chers étudiants, le cours d'aujourd'hui s'intitule l'écéphalée et algives vasculaires de la face. Donc tout d'abord, il faut savoir que l'écéphalée ou les algives vasculaires de la face est un problème très très fréquent, on pratique de tous les jours chez le neurologue mais principalement chez le médecin généraliste et chez d'autres spécialistes qui sont amenés à voir ce type de patients. Donc ça touche 30% de la population générale et sachez que presque, donc au Maroc, si on est 36 millions d'habitants, donc on doit avoir 12 millions de personnes qui souffrent d'écéphalée qui vont souffrir d'écéphalée.

Les céphalées primaires elles sont idiopathiques, donc ils n'ont pas de causes malignes, etc. Donc c'est en général soit chronique, soit elles sont permanentes ou paroxystiques Comme l'écéphalée de tension, l'hémigrène, l'écéphalée sans anomalies structurales, comme l'écéphalée liée au froid, à la chaleur, à la toux, au rapport sexuel, etc. Et donc c'est la majorité pour lesquelles il n'y a besoin d'aucun examen complémentaire et juste d'une prise en charge adaptée.

Et les 10% restants, c'est ça l'écéphalée symptomatique ou secondaire et ce sont vraiment celles-là qu'il faut prendre très au sérieux et on va parler tout à l'heure des signes et des drapeaux rouges Donc souvent ça peut être aiguë comme le cas de méningite, hémorragie méningée ou problème oculaire ou de névrite optique problème d'encéphalite, d'accident vasculaire, d'hématome ou bien ça peut être chronique comme les hypertensions intracrâniennes, les tumeurs, la maladie d'hortone, les causes métaboliques ou médicamenteuses Donc le diagnostic d'une céphalée ou d'une algée vasculaire de la face, il faut d'abord faire un bon anamnèse qui est complet, il doit axer sur les symptômes d'alarme ou les drapeaux rouges donc c'est les céphalées de type nouveau, d'intensité croissante, de fréquence croissante, de céphalée continue, de début soudain explosif qui doit évoquer l'hémorragie méningée des constamment homolatérales ou de céphalées à localisation très circonscrite et les symptômes d'accompagnement c'est soit des nausées âgées qui vont être récidivantes modification de la personnalité, des crises d'épilepsie, une altération d'état général fièvre, perte pendérale, troubles de la vue, de l'équilibre ou de l'élocution et donc toujours ne pas oublier aussi que l'examen clinique pourra mettre en évidence sur plan neurologique ou somatique des signes d'alarme ou des drapeaux rouges comme déficit neuropsychologique une stage ou aneudème papillaire, un syndrome méningé, un déficit neurologique focal, oculomoteur, paralysie, parésie troubles moteurs sensitifs aphasique, fièvre, vitesse d'alimentation augmentée, anémie ou bien une artère temporale non battante ou sinueuse et là je parle directement de la nouvelle classification des céphalées, des algies vasculaires et des algies faciales de la société mondiale des céphalées International Headache Society qui a démarré déjà en 1988 par la première classification qui a été actualisée en 2016 C'est l'ICD-3-beta et donc là vous avez l'article à droite qui parle de cette céphalée, vous pouvez le télécharger gratuitement et ça partage toutes les

céphalées en 14 groupes comme vous le voyez et c'est surtout les quatre premiers groupes qui constituent 90% de toutes les céphalées, c'est ce qu'on appelle les céphalées primaires ou idiopathiques migraines, céphalées de tension, algies vasculaires dans la face ou clusters headache, céphalées liées à des anomalies non structurelles céphalées liées au froid rapport sexuel à la toux etc et vous voyez les 10% restants, c'est les céphalées secondaires qu'on va voir dans les principales, c'est surtout les causes traumatiques vasculaires liées au processus intracrânien, aux causes toxiques, aux abus de médicaments, les causes d'origine métabolique le groupe 11 c'est les céphalées du spécialiste, ils sont là aussi très fréquentes sinusites, otites uveïtes, problèmes de dents de sagesse, de l'articulation temporomandibulaire et le deuxième groupe c'est celui des troubles psychiatriques avec céphalées et après c'est les névralgies idiopathiques, il y a toujours un groupe inclassable c'est le quatorzième groupe donc on commence par la migraine, la migraine sachez qu'elle touche 20 à 30% de toutes les céphalées donc c'est des migraines et là vous avez une thèse qu'on avait faite, on en a fait 3 et donc celle là c'est en 2017 qui donne la prévalence de la migraine dans notre pratique et donc on l'a chiffrée grâce aux consultations chez les médecins généralistes donc qui était chiffrée à 13% et donc c'est une thèse qui a été soutenue mais qu'on n'a pas encore publié et sachez que cette maladie qui est chronique, qui touche surtout le sexe féminin, familial souvent et donc elle est aussi caractérisée par des facteurs déclenchants qui peuvent être psychiques, tensions, conflits etc avec fréquemment des accès au moment de la détente et de la relaxation il y a aussi les facteurs alimentaires et c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle la migraine comme la crise de foie souvent les gens ils se vomissent beaucoup, ils voient le gastro et on fait un tas de bilans il faut savoir que les aliments riches en amines vasopressives sont des facteurs déclenchants donc comme le fromage, le chocolat etc. Là c'est l'immunologie des axes migraineux Donc la migraine commune c'est les trois quarts de toutes les migraines et les communes est faite d'accès de céphalées avec hémicrânie atroce donc vraiment c'est comme des coups de marteau sur la moitié du crâne la survenue est souvent annoncée par des prodromes, des au revoir des jours avant la céphalée et des troubles digestifs, anorexie modification de l'humeur sensorielle et en particulier par la lumière avec photos et phonophobie Intense, elle empêche toute activité physique, ça aussi c'est une question qu'il faut poser aux malades, aggravée par les efforts de l'atout et l'éternuement. Chez un même malade les accès parfois sont hémicrâniens mais parfois ils peuvent être bilatéraux mais il y a toujours une nette prédominance d'un côté.

Elle est accompagnée d'un état nauséux, éventuellement de vomissement qui calme la céphalée et les crises durent en général de 4 à 72 heures et vous avez une aggravation lors des règles et amélioration par la grossesse et là il faut exiger au moins cinq crises parmi donc ces critères il faut au moins avoir deux c'est à dire soit un siège hémicrânien type pulsatile, intense ou moyenne intense moyenne intensité et durée de 4 à 72 heures et avoir un parmi les autres signes c'est à dire non zévroissement et ou photophobie et ou phonophobie c'est à dire la personne ne supporte ni la lumière ni le bruit Les formes cliniques de la migraine donc vous avez les migraines qu'on a vu typique c'est les plus fréquentes 75% mais sachez que 25% c'est des migraines avec aura donc l'aura peut-être visuelle c'est la plus fréquente c'est des symptômes qui

précèdent la céphalée ils peuvent parfois l'accompagner ou venir après et retenir qu'il y a ce qu'on appelle la marche migraineuse qui se fait en minutes d'ailleurs c'est le symptôme que vous voyez en photo comme des scènes colorées, comme des images, comme une sorte de mirage etc et ça démarre très progressivement il faut pas que ça démarre ou que ça apparaisse en moins de cinq minutes il faut que ça dépasse cinq minutes parce que sinon ça peut être l'épilépsie d'ailleurs une diagnose différentielle c'est la marche épileptique qui se fait en secondes et après le total de ces phénomènes visuels ne doivent pas durer plus d'une heure et donc vous allez avoir ces troubles qui vont précéder la céphalée et vous allez avoir parfois des symptômes négatifs ou positifs c'est à dire ce qu'on appelle un scotome c'est comme une tâche noire c'est négatif ou bien avec des lumières des éclairs c'est positif et l'hémianopsie c'est le deuxième grand type de troubles visuels au cours de la migraine ophthalmique il peut apparaître d'emblée scotome et parfois l'axe migraineux se limite aux troubles visuels initiaux sans phénomène céphalalgique secondaire Vous avez d'autres migraines avec aura ils peuvent être ophthalmopariétales avec les mêmes mécanismes de commencement et de progression hémipariétales somatosensitifs aphasiques comme une perte de langage plus exceptionnellement vertébrovasculaires avec vertiges troubles cérébelleux paralysées oculomotrices mais tout va régresser c'est pour ça où il faut penser à la migraine mais quand c'est le premier épisode vous avez le droit de demander des examens complémentaires Parce que là il y a le risque d'AVC qui est le principal diagnostic différentiel les migraines de l'enfant ils sont très particulières parce que les crises sont dominées par les troubles digestifs en particulier les douleurs abdominales diarrhée vomissement et vous avez les complications de la migraine c'est surtout l'état de mal migraineux qui doit durer plus de 72 heures et vous avez l'infarctus migraineux d'ailleurs actuellement la migraine est considérée comme un facteur de risque cardiovasculaire Et là c'est quand vous avez des signes durables et vous avez un foyer ischémique sur le plan de l'imagerie et vous voyez sur le plan explication parce qu'il y a beaucoup d'intrication avec les peptides et avec des phénomènes inflammatoires au niveau des vaisseaux intracrâniens Les examens complémentaires bien sûr devant une migraine typique avec les critères rassemblés vous n'avez aucune raison de demander un examen clinique ou paraclinique plutôt vous demandez l'examen clinique mais pas paraclinique mais quand vous avez des signes atypiques ou des drapeaux rouges comme on avait vu c'est là où vous demandez des examens complémentaires donc sachez que le gros des données c'est l'interrogatoire principalement et l'examen il est souvent normal sauf si c'est un peu l'angoisse et la photophobie, la personne qui se cache la lumière quand c'est au cours de la crise migraine Sur le plan maintenant du traitement donc le traitement de la crise migraineuse donc sachez déjà que le traitement il y a trois volets, il y a le traitement de la crise quand vous avez moins de deux crises par mois, par exemple une crise par trois mois, une crise par mois vous avez le traitement de fond c'est quand vous avez plus de crise ou plus par mois vous avez le traitement des facteurs déclenchants donc le traitement de la crise c'est surtout les salicylés ou l'aspirine ou les anti inflammatoires comme vous le voyez sur le tableau donc on donne aussi un anti-émétique le métoclopramide, on donne les anti-inflammatoires, les buprénorphines, le kétoprénophène sont

très efficaces Vous avez des troubles secondaires, troubles digestifs, allergie, il faut faire très attention les contre-indications pour les anti-inflammatoires non stéroïdiens c'est l'ulcère, la grossesse bien sûr, plus de 24 semaines et surtout par exemple il y a aussi les triptans en général on ne donne pas plus de deux par jour et c'est des médicaments qui coûtent cher mais très très efficaces l'almotriptan, l'élitriptan et leur avantage c'est qu'ils sont très spécifiques au niveau des récepteurs 5HT au niveau crânien donc ça donne moins d'effets secondaires comme vous le voyez bien sûr les contre-indications, surtout les coronaryopathies, les AVC, les AIT etc donc l'élitriptan vraiment c'est des médicaments miracles je dirais qui améliorent les malades et en général au lieu que la personne va souffrir pendant trois jours là vous allez arrêter la crise au bout de 10-15 minutes et vous avez donc beaucoup de produits commercialisés au Maroc comme le migrix, comme le le sumatriptan, comme le zolmitriptan, comme le relpax donc vraiment très très efficace le deuxième volet du traitement c'est le traitement préventif donc quand vous avez des crises très nombreuses par exemple plus de ou plus par mois 3 ou 5 ou 1 par 3 jours et donc là il fait appel surtout aux dérivés de l'ergot de seigle, des hydro-herbotamines mais faire attention parce que certains produits donc qu'on ne trouve plus dans le marché, il y a aussi des bêta bloqueurs et l'avantage là c'est par exemple si vous avez un patient anxieux avec tachycardie, avec hypertension, ben là vous allez profiter des effets secondaires des bêta bloqueurs comme le propranolol il y a aussi les antagonistes de la sérotonine, le métisérigide et quand vous avez un profil dépressif c'est mieux d'utiliser des antidépresseurs comme le laroxyl qui est un antidépresseur tricyclique efficace comme traitement de fond Et là au moins il faut donner le traitement pendant 3 à 4 mois et en dernier lieu le traitement des facteurs déclenchant qui est capital le repos, éviter le stress, la lumière, le bruit et surtout avoir une vie équilibrée, pas trop reposante, les gens par exemple qui passent leur temps à rester dans leur lit à ne rien faire ou pas très stressante et lutter contre les facteurs psychogènes alimentaires, hormonaux par exemple Les règles, on peut parfois même proposer une hormonothérapie chez les femmes qui ont ce qu'on appelle la migraine cataméniale donc là on a vu la migraine, maintenant on va voir un deuxième groupe qui est celui des algives vasculaires de la face et on l'a vu parce que c'est pas le plus fréquent, le plus fréquent c'est les céphalées de tension qu'on va voir juste après mais c'est parce que ça se rapproche le plus de la migraine et la différence en fait c'est exactement comme la migraine des accès de douleurs sauf qu'ils sont un peu de durée moindre en général ça part de 30 minutes à 3 heures alors que la migraine on a vu c'est 4 heures à 72 heures et surtout il y a la richesse des signes vasomoteurs comme vous avez sur l'image donc là qui peuvent être un larmohamon ou des douleurs et c'est là c'est constamment de homolatéral donc c'est le même côté et vous allez avoir le larmohamon, le signe de Claude Bernard Horner, une obstruction nasale et ça débute en général chez les jeunes de 15 à 40 ans sans caractère familial à la différence de la migraine et là ils sont très très sensibles aux anti inflammatoires l'endométacine et les autres formes et aussi sensibilité aux anti migraineux et aux bêtas bloqueurs et aux triptons et parfois on peut même avoir recours à l'oxygène qui est aussi très efficace dans ces formes là le troisième groupe c'est celui des céphalées de tension mais c'est le plus fréquent donc là je vous ai écrit qu'on croise c'est presque les deux tiers de toutes les

céphalées Et en fait c'est des céphalées qui sont fugaces, étranges, d'une intensité différente chez chaque personne et ça se positionne en différents endroits là où il y a la richesse de muscles par exemple la partie inférieure postérieure de la tête, le vertex, en bitemporale, en casque rarement à la voûte supérieure du crâne et différentes causes peuvent engendrer des céphalées comme par exemple le stress, des contractures musculaires ou parfois quelques tensions mécaniques inflammatoires, il y a des facteurs aussi alimentaires, digestifs traumatologiques mais surtout psychologiques ou allergiques et leur traitement doit insister sur l'origine de la tension en plus des ontologiques, anxiolytiques, antidépresseurs et souvent chez un malade céphalologique il faut chercher l'épine irritative qui va vous dire qu'il y a un problème sous-jacent à traiter Le quatrième groupe c'est celui des névralgies faciales et là vous avez sur le schéma les différents trajets du nerf facial c'est vrai vous avez le 5 1 au niveau frontal, le 5 2 c'est ce qui est figuré avec les deux troisième quatrième doigt et vous avez le 5 3 avec le premier deuxième doigt sur l'image et donc c'est des douleurs au niveau du territoire du trigeminal, ça peut être tout le nerf, ça peut être une branche et la névralgie est vraiment atroce, ça ne dure même pas une seconde, c'est des douleurs extrêmes vraiment parfois syncopales parfois et donc sachez qu'il y a des névralgies essentielles ou idiopathiques qu'on va commencer à voir les premières parce que c'est les plus fréquentes et ça touche surtout le sujet d'un âge avancé 50 ans et plus dans plus de trois quarts des cas et parfois pourra même débuter après 70 ans avec une prédominance féminine et le mécanisme c'est en général idiopathique mais parfois on peut trouver un conflit vasculonerveux dans le ventre, pons ou cérébellum Dans la sémiologie, vous allez avoir des crises douloureuses hyperalgiques comme une décharge électrique et chaque accès va durer environ une seconde et vraiment ça peut être des salles parfois répétées telles que le malade sèche de toute activité, s'immobilise, entre les accès le malade ne ressent aucun symptôme et pour la névralgie idiopathique outre le type de la douleur et l'âge Vous avez les éléments évocateurs, c'est la topographie donc c'est en général le territoire du 5,2 du maxillaire supérieur plus de 40% des cas, le mode de déclenchement vous avez en fait ce qu'on appelle la zone gâchette, c'est à dire une zone dès que vous la touchez ça va vous déclencher la décharge, parfois ça peut être l'alimentation, le rire, la parole et l'examen clinique est entièrement négatif donc le branchement 5 motrices, 5 sensitifs, le réflexe cornea tout est normal et d'ailleurs c'est un élément de diagnostic différentiel avec les névralgies sympathiques l'évolution bien sûr elle est très favorable sous traitement à base de carbamazépine ou des autres antihépileptiques mais parfois il y a des situations où on peut aller au traitement chirurgical sur le plan de traitement il y a le traitement médical, donc c'est principalement la carbamazépine ou c'est générique, Tégrétol ou c'est générique comme la carbamazépine normand, comme l'alépsia, la crise épine en général on peut aller de 200 à 400 jusqu'à 600 ou plus, aller à des doses progressives donc c'est un véritable test diagnostique en général ça permet de calmer la douleur dans plus de 70% des cas mais il y a tous les autres antihépileptiques qui sont efficaces et même les nouvelles molécules comme la gabapentine et autres produits. Et le traitement chirurgical quand il y a un échec du traitement médical on peut faire des neurotomies on peut faire aussi des thermocoagulations et là maintenant il y a aussi d'autres techniques vraiment non invasives et

très très efficaces Donc là on a vu les névralgies idiopathiques qui sont les plus fréquentes, bien sûr tout d'abord il faut penser à éliminer les névralgies symptomatiques du trisumeaux et là qui peuvent toucher d'autres branches autres que le 5-2 ou même le 5-2 et c'est en général le sujet jeune avant 50 ans et il faut chercher des anomalies à l'examen par exemple la zone gâchette qui va manquer ou une anomalie à l'examen et là il ne faut pas hésiter à demander une IRM avec enjeux IRM et surtout chercher est-ce qu'il n'y a pas de boucle vasculaire, un conflit entre le nerf trisumeaux et l'artère auditive interne il faut alors engager un bilan comportant, une IRM, mieux qu'un scanner cérébral ou éventuellement une enjeux IRM ou même une artério, l'APL avec études cytochimiques, électrovolets des protéines et surtout une exploration électrophysiologique et la névralgie peut être symptomatique d'une atteinte périphérique extracranienne, fracture, atteinte d'un nerf, un neurinome ou un problème central bulbeaux protubérantiels, il y a aussi la sclérose en plaques qui peut donner des névralgies donc il s'agit parfois de la première poussée et des tumeurs infiltrantes donc d'où l'intérêt du bilan parac l'encephalite du spécialiste c'est quand même très très fréquent par exemple chez l'ophtalmo on peut avoir les uveïques, les glaucomes la lèvrte optique qui est un problème neurologique, chez l'ORL on peut avoir des sinusites, les otiques, les pulpites, les ethmoïdites donc tout ça ça peut donner des céphalites, il y a aussi le problème stomatologique, les accidents de la dent de sagesse, les absédentaires ou l'écosystémique pneumonie, piélo-néphrite etc. Et vous avez à droite donc des images par exemple de sinusites sur l'image de gauche en bas et à droite vous avez un sinus tout à fait normal et ça ça peut donner des douleurs localisées au niveau des sinus et surtout aggravées par la position proclive et parfois même sans fièvre et il faut y penser et vous avez aussi donc on va parler rapidement de d'autres céphalites symptomatiques donc pour les résumer c'est surtout les causes traumatiques vasculaires, les AVC ischémiques mais surtout hémorragiques, les hémorragies méningées, l'artérite de Horton, les crises hypertensives, les thrombophilités, des sinus et des veines cérébrales, l'hypertension intracrânienne, comme on le sait les méninges sont très énervés, le cerveau bien sûr lui il n'a pas d'innervation c'est pour ça que une tumeur intra-parenchymatose isolée sans hydrocéphalie parfois vous n'avez jamais de céphalite jusqu'à l'apparition du déficit l'hypertension intracrânienne bénigne, l'hypotension intracrânienne, là aussi quand vous avez la pression intracrânienne qui baisse, par fistule durale ou postponction lombaire inflammatoire, lupus, granulone, infectieuse, méningite, encéphalite, abcès ou tumorale et à droite vous avez une image d'hydrocéphalie en haut et en bas une image d'un méningiome on le connaît très bien par sa base d'implantation sur la dure-mère et vu qu'il s'accroche sur la dure-mère donc il va s'accompagner de... Et donc là il s'agit de groupes où les examens paracliniques s'imposent et là vous avez le scanner cérébral à chaque fois que vous avez des signes d'alarme ou des drapeaux rouges suspicion de méningite, d'artéritétemporale, d'AVC, le scanner peut suffire mais en général c'est l'IRM qu'il faut demander par exemple les thromboflébités, les problèmes de tumeur du tronc cérébral, etc.

les malformations artério-veineuses, les anévrismes ou même un scanner avec un geoscaner ou l'artériographie qui peut montrer par exemple tout ce qui est anévrismes, fistules, etc. et vous avez par exemple sur l'image en haut à droite une tumeur avec compression de l'acudium, plutôt

de trop de moraux et donc ça va s'accompagner de céphalée et d'hydrocéphalie après et en bas c'est une IRM avec un geo-IRM et vous avez une thromboflébite du sinus longitudinal supérieur montré par les flèches et là aussi ça va s'accompagner de céphalée. On peut aussi demander la ponction lombaire en cas de céphalée avec fièvre et de suspicion de méningite ou méningocéphalite, la vitesse de sédimentation lorsque toute céphalée inaugurale chez un patient de plus de 50 ans et d'autres investigations selon le contexte.

Et en conclusion, parmi toutes les céphalées, sachez que 50 à 60% sont psychogènes ou de tension qui ne nécessitent aucun examen complémentaire de même que 20 à 30% c'est des migraines, donc presque 90% c'est des céphalées de tension ou des migraines et des céphalées liées à des anomalies non structurelles, au froid, à la chaleur, à la givascularie de la face et les 10% restants c'est ça les céphalées symptomatiques qui peuvent donc justifier un bilan paraclinique et la hantise c'est de passer à côté d'une céphalée symptomatique et l'aberration c'est de demander trop d'examens complémentaires inutiles devant les 90% des céphalées non symptomatiques Et là je résume, il faut faire un interrogatoire minutieux, un bon examen neurologique somatique, une bonne connaissance des différentes causes des céphalées et surtout assurer une bonne prise en charge